Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**
**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ**

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ»

**ТАШКЕНТ – 2025**

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ»

**ТАШКЕНТ – 2025**

"СОГЛАСОВАНО"
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Х.Г. Фозилов

_____ _____ 2025 год

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ»

**ТАШКЕНТ 2025**

## Национальный клинический стандарт медицинской помощи по нозологии

# ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

| Кодирование по МКБ-10: | Нозология | Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в амбулаторных условиях | | Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в стационара условиях | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Основной специалист | Консультирующие специалисты | Основной специалист | Консультирующие специалисты |
| I20.0, I20.9 | Нестабильная стенокардия | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 | Острый инфаркт миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9 | Повторный инфаркт миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8 | Осложнения инфаркта миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |

| Кодирование по МКБ-11: | Нозология | Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в амбулаторных условиях | | Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в стационара условиях | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Основной специалист | Консультирующие специалисты | Основной специалист | Консультирующие специалисты |
| BA40.0 | Нестабильная стенокардия | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA41 | Острый инфаркт миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA41.0 | Острый инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA41.1 | Острый инфаркт миокарда без подъёма сегмента ST | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA41.Z | Острый инфаркт миокарда неуточнённой локализации | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | | реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA42 | Инфаркт миокарда как осложнение | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA42.0 | Инфаркт миокарда как осложнение, STEMI | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA42.1 | Инфаркт миокарда как осложнение, NSTEMI | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA42.Z | Инфаркт миокарда как осложнение неуточнённое | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA43 | Коронарный тромбоз, не приведший к инфаркту миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | эндокринолог, нефролог, окулист | | эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA4Z | Острая ишемическая болезнь сердца неуточнённая | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA50 | Перенесенный инфаркт миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |
| BA60, BA60.0, BA60.1, BA60.2, BA60.3, BA60.4, BA60.5, BA60.6, BA60.7, BA60.8, BA60.9, BA60.Y, BA60.Z | Текущие осложнения острого инфаркта миокарда | ВОП/Терапевт/Кардиолог | Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист | Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог | Интервенционный кардиолог, кардиожарроҳ, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист |

***В процессе заполнения стандарта требуется учитывать нозологию, ее проявления у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также характер течения заболевания в зависимости от его стадии.**

**Кроме того, не рекомендуется заполнять таблицы, которые не соответствуют данной нозологии. (Например, если хирургическое вмешательство не проводится в рамках нозологии (таблицу "ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО" заполнять не нужно), или если в нозологии не предусмотрено паллиативное лечение – таблицу "ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ" также не следует заполнять.)**

## МЕРОПРИЯТИЯ по ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

| Диагностические мероприятия | Наименование медицинской услуги | Уровень и тип медицинской помощи | | | | | Минимальное количество проводимых услуг или обследований | Срок лечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | | | |
| | | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Районные (городские) больницы | Учреждения здравоохранения областного уровня | Учреждения здравоохранения республиканского уровня | | |
| Осмотр основного специалиста (врача) | 1. Семейный врач | + | | | | | | Амбулаторное наблюдение пожизненно Стационарное лечение: 10-14 дней* |
| | 2. Кардиолог | | + | + | + | + | | |
| | 3. Терапевт | | | + | | | | |
| Примечание: * Срок лечения в стационаре зависит от целей госпитализации. Специализированные осмотры в стационаре проводятся ежедневно. | | | | | | | | |
| Осмотр специалиста (врача) (консультирующего) | 1. Интервенционный кардиолог | | | | + | + | По показаниям | |
| | 2. Кардиохирург | | | | + | + | По показаниям | |
| | 3. Интервенционый аритмолог | | | | | + | По показаниям | |
| | 4. Невропатолог | | | + | + | + | По показаниям | |
| | 5. Эндокринолог | | | + | + | + | По показаниям | |
| | 6. Нефролог | | | + | + | + | По показаниям | |
| | 7. Окулист | | | + | + | + | По показаниям | |
| Примечание: Все узкие специалисты приглашаются по показаниям. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Количество осмотров узких специалистов в стационаре должно определяться в зависимости от клинического состояния..** | | | | | | | | |
| **Основные лабораторные исследования** | **1. Общий анализ крови** | | | + | + | + | **По показаниям** | |
| | **2. Общий анализ мочи** | | | + | + | + | | |
| | **3. Креатинин крови** | | | + | + | + | | |
| | **4. АЛТ, АСТ, билирубин** | | | + | + | + | | |
| | **5. Уровень глюкозы в крови** | | | + | + | + | | |
| | **6. Общий холестерин** | | | + | + | + | | |
| | **7. Триглицериды** | | | + | + | + | | |
| | **8. ЛПВП Хс** | | | + | + | + | | |
| | **9. ЛПНП-Хс** | | | + | + | + | | |
| | **10. Общая КФК** | | | + | + | + | | |
| | **11. Коагулограмма** | | | + | + | + | | |
| | **12. Тропонины** | | | + | + | + | | |
| **Примечание: Количество лабораторных исследований в стационаре определяется в зависимости от клинического состояния.** | | | | | | | | |
| **Қўшимча лаборатор текширувлар** | **1. МВ-КФК** | | | + | + | + | **По показаниям** | |
| | **2. RW** | | | + | + | + | | |
| | **3. Группа крови** | | | + | + | + | | |
| | **4. Гепатит В и С** | | | + | + | + | | |
| | **5. ВИЧ** | | | + | + | + | | |
| | **6. МНУП** | | | + | + | + | | |
| | **7. ТТГ** | | | + | + | + | | |
| | **8. Гликированный гемоглобин** | | | + | + | + | | |
| | **9. Электролиты** | | | + | + | + | | |
| | **10. Общий белок** | | | + | + | + | | |
| | **11. КЩС** | | | + | + | + | | |
| **Примечание: Исследования на определение группы крови, наличие гепатита В и С, а также на ВИЧ должны проводиться для пациентов, которым планируется коронароангиография (КАГ) и/или реваскуляризация миокарда (ЧКВ или АКШ). Количество лабораторных исследований в стационаре определяется в зависимости от клинического состояния пациента.** | | | | | | | | |
| **Основные инструментальные исследования** | **1. ЭКГ** | + | + | + | + | + | **По показаниям** | |
| | **2. ЭхоКГ** | | | | + | + | **1, затем по показаниям** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Инвазивная коронарография | | | | + | + | По показаниям | |
| Примечание: В условиях стационара количество ЭКГ определяется в зависимости от клинической ситуации. | | | | | | | | |
| | 1. Рентгенография органов грудной клетки | | | + | + | + | | |
| | 2. Допплерография БЦА | | | + | + | + | | |
| | 3. ХМЭКГ | | | | + | + | | |
| | 4. Фракционный резерв кровотока (FFR) | | | | | + | | |
| | 5. ЭГДФС | | | + | + | + | | |
| | 6. УЗИ внутренних органов | | | + | + | + | | |
| Примечание: ЭГДФС необходимо выполнять в условиях реанимации при наличии абсолютных признаков гастродуоденального кровотечения. | | | | | | | | |

| Диагностические мероприятия | Название медицинского исследования | Уровень и тип медицинской помощи | | | | | Минимальный объём исследования | Продолжительность лечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | | | |
| | | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Районные (городские) больницы | Учреждения здравоохранения областного уровня | Учреждения здравоохранения республиканского уровня | | |
| Другие исследования | 1. TIMI шкала | | | + | + | + | При первом осмотре | |
| | 2. GRACE шкала | | | + | + | + | При первом осмотре | |
| | 3. CHA2DS2-VASc и HAS-BLED шкалы | | | + | + | + | При каждом осмотре | |
| | 4. SYNTAX score | | | + | + | + | После проведения коронарной | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ангиографии (КАГ) используется для определения вида реваскуляризации миокарда | |

**Примечание:** Шкала TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) используется для оценки риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом.
Шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) также применяется для оценки прогноза пациентов с острым коронарным синдромом, учитывая клинические данные и результаты обследования
Для оценки риска ишемического инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий используется шкала CHA2DS2-VASc.
Шкала HAS-BLED применяется для оценки вероятности кровотечения при использовании пероральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий
Шкала SYNTAX используется для оценки анатомической сложности коронарного поражения и прогнозирования исходов у пациентов, подверженных коронарному шунтированию или баллонной ангиопластике

**(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ)**

| Лечебные мероприятия (Основные медикаментозные препараты | | Уровень и тип медицинской помощи | | | | | Средняя суточная дозировка | Курсовая дозировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | | | |
| | | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Районные (городские) больницы | Учреждения здравоохранения областного уровня | Учреждения здравоохранения республиканского уровня | | |
| Название лекарственного средства (международное непатентованное) | Дозировка и применение лекарственного средства." | | | | | | | |
| 1. Антиагреганты<br>- Ацетилсалицилловая кислота | Ацетилсалицилловая кислота нагрузочная доза 150-300 мг, затем | + | + | + | + | + | 75-150 мг | пожизненно |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Клопидогрел<br>- Тикагрелор<br>- Прасугрел | по<br>75-150 мг 1 раз в суткаи | | | | | | | |
| | Клопидогрел нагрузочная доза 300 мг, бемор >75 ёш - 75 мг.<br>75 мг 1 раз в сутки<br>или | + | + | + | + | + | 75 мг | 1 йил* |
| | Тикагрелор нагрузочная доза 180 мг, затем<br>90 мг 2 раз в сутки<br>или | | | + | + | + | 180 мг | 1 йил* |
| | Прасугрел 5-10 мг 1 раз в сутки | | | + | + | + | 5-10 мг | 1 йил* |
| 2. Антикоагулянтлар:<br>- Нефракционированный гепарин<br>- Эноксапарин | Нефракционированный гепарин (НФГ) болюс 60-70 ЕД/кг (но не более 5000 ЕД) в/и, затем в/в инфузия с начальной скоростью 12-15 ЕД/кг/ч (но не более 1000 ЕД/кг/ч). В последующем доза подбирается по АЧТВ, которое должно превышать контрольное для данного реактива в 1,5-2,5 раза<br>затем/или | + | + | + | + | + | Согласно инструкции | 5-7 кун |
| | -Эноксапарин 1 мг/кг, 2 раз в сутки т/о | | | + | + | + | Согласно инструкции | - |
| 3. тромболитиклар[6] | Стрептокиназа 1 500 000 МЕ | | | + | + | + | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тенектеплаза 40 мг (8 000 ЕД/ 50 мг (10 000 ЕД)** | | | | | | | |
| **4. Диуретики[1]** | **Фуросемид 10 мг/мл (амп 2 мл) Фуросемид таб. 40 мг Торасемид 20 мг/4 мл Торасемид таб. 5 мг, 10 мг** | | | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | **-** |
| **5. Нитраты: - Нитроглицерин - Изосорбида динитрат[2,5]** | **- Нитроглицерин: а) 0,1-1,2 мг применяется только при приступах стенокардии сублингвально в форме таблетки или спрея б) ампула 0,1%-1 мл - Изосорбида динитрат 0,1%-10 мл** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | **-** |
| **6. Антиаритмические препараты[2]** | **-Амиодарон 150 мг /3 мл Амиодарон 150 мг. - Лидокаин 20 мг/мл - Эсмолол 10 мг/мл** | | | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | |
| **7. Адренергические и дофаминергические средства[1,5]** | **Добутамин 250 мг/50 мл Допамин 40 мг/мл Норэпинефрин 2 мг/мл Эпинефрин (адреналин) 1 мг/мл** | | | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | |
| **8. Наркотические анальгетики[2]** - | **-Морфин 10 мг/1 мл -Промедол 10 мг/1 мл Фентанил 50 мкг/1 мл** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | |
| **9. Алкалоиды белладонны третичные амины** | **Атропина сульфат 0,1% 1 мл[4]** | | | **+** | **+** | **+** | **По показаниям** | **-** |
| **10. Статины** | **- Розувастатин 5-40 мг 1** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **- Розувастатин 5-40** | **пожизнен** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Розувастатин<br>- Аторвастатин | раз в сутки<br>- Аторвастатин 10-80 мг 1 раз в сутки | | | | | | мг<br>- Аторвастатин 10-80 мг | но |
| 11. РААТ блокаторы[7]:<br>А) АПФ ингибиторы:<br>- Эналаприл<br>- Рамиприл<br>- Периндоприл<br>Б) АРБ (сартаны):<br>- Валсартан<br>- Лозартан<br>- Кандесартан<br>- Телмисартан<br>- Азилсартан<br>- Олмесартан | ААФи:<br>- Эналаприл 2,5-20 мг суточная доза разделяется на два приёма<br>- Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в сутки<br>- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>АРБ:<br>- Валсартан – 40-320 мг суточная доза разделяется на два приёма<br>- Лозартан 25-100 мг 1 раз в сутки<br>- Кандесартан 4-32 мг 1 раз в сутки<br>- Телмисартан 10-80 мг 1 раз в сутки<br>- Азилсартан 20-80 мг 1 раз в сутки<br>- Олмесартан 10-40 мг 1 раз в сутки | | | + | + | + | ААФи:<br>- Эналаприл 2,5-20 мг<br>- Рамиприл 2,5-10 мг<br>- Периндоприл эрбумин 2-8 мг<br>- Периндопил аргинин 2,5-10 мг<br>АРБ:<br>- Валсартан – 40-320 мг<br>- Лозартан 25-100 мг<br>- Кандесартан 4-32 мг<br>- Телмисартан 10-80 мг<br>- Азилсартан 20-80 мг<br>- Олмесартан 10-40 мг | пожизненно |
| 12. Бета-блокаторы:<br>- Бисопролол<br>- Метопролол<br>- Небиволол<br>- Карведилол | - Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в сутки<br>- Небиволол 2,5-10 мг 1 раз в сутки | | | + | + | + | - Бисопролол 2,5-10 мг<br>- Метопролол сукцинат 25-100 мг<br>- Небиволол 2,5- | пожизненно |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Карведилол 3,125-25 мг суточная доза разделяется на два-три приёма | | | | | | 10 мг<br>- Карведилол 3,125-25 мг | |
| 13. Блокаторы дигидропиридиновых кальциевых каналов:<br>- Амлодипин<br>- Лерканидипин<br>- Нифедипин пролонгированного действия | - Амлодипин 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Лерканидипин 5-20 мг 1 раз в сутки<br>- Нифедипин ретард 30-60 мг 1 раз в сутки | | | + | + | + | - Амлодипин 2,5-10 мг<br>- Лерканидипин 5-20 мг<br>- Нифедипин ретард 30-60 мг | |
| 14. АМКР:<br>- Спиронолактон<br>- Эплеренон | - Спиронолактон 25-100 мг, 1-3 раза в сутки<br>- Эплеренон 25-50 мг, 1 раз в сутки | | | + | + | + | - Спиронолактон 25-200 мг<br>- Эплеренон 25-50 мг | пожизненно |

**Примечание: * в течение1 года, для пациентов с ОКС перенесших ЧКВ или АКШ**

**[1]Применяется у больных с острой сердечной недостаточностью и/или с гемодинамической нестабильностью.**

**[2] Схема назначения лекарственных средств определяется в соответствии с показаниями и тяжестью заболевания.**

**[3.] Применяется при желудочковой экстрасистолии 4А, 4В или 5 класса по Лауну.**

**[4.] Применяется в случаях брадикардии при гемодинамической нестабильности.**

**[5.] Инфузия нитратов используется в случаях сердечной недостаточности с вышеуказанными состояниями и/или при сохранении ишемии миокарда и/или гипертензии.**

**[6.] Тромболитическая терапия проводится согласно показаниям (смотрите протокол).**

**[7.] Бета-адреноблокаторы применяются у пациентов с ОКС, АГ, СД и ХСН.**

**В случае передозировки гепарина, применить протамина сульфат 10 мг/мл, согласно инструкции**

**В процессе лечения больного, если возникает необходимость в использовании медикаментов, не указанных выше, это может быть введено на основании консилиума.**

**Если в амбулаторных условиях по клиническим данным и ЭКГ подозревается ОКС, то необходимо оказывать первую помощь с амбулаторного уровня.**

| Лечебные мероприятия (Дополнительные медикаментозные препараты | Уровень и тип медицинской помощи | | | | | Средняя суточная дозировка | Курсовая дозировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | | | |
| | | | Районные | Учреждения | Учреждения | | |

| | | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | (городские) больницы | здравоохранения областного уровня | здравоохранения республиканского уровня | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Название лекарственного средства (международное непатентованное)** | **Дозировка и применение лекарственного средства."** | | | | | | | |
| **1. Ривароксабан** | **15-20 мг 1 раз в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **15-20 мг** | **пожизненно**** |
| **2. Апиксабан** | **2,5-5 мг 2 раз в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **5-10 мг** | **1 йил** |
| **3. Фенофибрат** | **145 мг 1 раз в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **145 мг** | **пожизненно** |
| **4. Омега 3** | **1 г по 2 капсулы 2 раза в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **4 г** | **пожизненно** |
| **5. Ингибиторы протонного насоса<br>- Омепразол<br>- Пантопразол<br>- Рабепразол<br>- Эзомезопразол** | **-Омепразол 20 мг1 раз в сутки<br>-Пантопразол 40 мг1 раз в сутки<br>-Рабепразол 20 мг1 раз в сутки<br>-Эзомепразол 20 мг** | | | **+** | **+** | **+** | **-Омепразол 20 мг1 раз в сутки<br>-Пантопразол 40 мг1 раз в сутки<br>-Рабепразол 20 мг1 раз в сутки<br>-Эзомепразол 20 мг** | **1 мес*** |
| **6. Триметазидин** | **80 мг 1 раз в сутки, 35 мг 2 раз в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **70-80 мг** | **пожизненно** |
| **7. Ранолазин** | **500-1000 мг 2 раз в сутки** | | | **+** | **+** | **+** | **1000-2000 мг** | **пожизненно** |
| **8. Метаболики[2]:<br>- Фруктоза-1,6-дифосфат[2]<br>- Фосфокреатин[2]<br>- мельдоний<br>- тиотриазолин** | **Схема назначения лекарственных средств определяется в соответствии с показаниями и тяжестью заболевания.** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9. Минеральные препараты, микроэлементы[2].**<br>**- Калия хлорид 40мг/мл**<br>**- Магния сульфат250 мг/мл** | **Схема назначения лекарственных средств определяется в соответствии с показаниями и тяжестью заболевания.** | | | | | | | |
| **10. Препараты для регидратации и дезинтоксикации Глюкоза** | **Схема назначения лекарственных средств определяется в соответствии с показаниями и тяжестью заболевания.** | | | | | | | |

**Примечание: Фенофибрат и Омега-3 препараты применяются при сочетании гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии.**

***Клопидогрель назначается на период до 1 года для пациентов перенесших острый коронарный синдром (ОКС), чрескожное коронарное вмешательство (КВ) или коронарное шунтирование (КШ). Если у пациента с ИБС высок риск сердечно-сосудистых осложнений, он может приниматься вместе с ацетилсалициловой кислотой пожизненно.**

****Ривароксабан и апиксабан могут назначаться назначаться, если у пациента с ОКС имеется ФП (фибрилляция предсердий.**

**[2] Схема назначения лекарственных средств определяется в соответствии с показаниями и тяжестью заболевания.**

**В процессе лечения больного, если возникает необходимость в использовании медикаментов, не указанных выше, это может быть введено на основании консилиума.**

**(ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)**

| Лечение (оперативное лечение) | Уровень и тип медицинской помощи | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | |
| Название хирургической операции/вмешательства/метода лечения | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Районные (городские) больницы | Учреждения здравоохранения областного уровня | Учреждения здравоохранения республиканского уровня |
| 1. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) | | | + | + | + |
| 2. Коронарное шунтирование (КШ) | | | | + | + |
| 3. Временная ЭКС | | | + | + | + |
| 4. Внутриаортальная баллонная контрпульсация (ВАБК) | | | | + | + |

Примечание: ЧКВ: инфаркт-связанной артерии, а также если коронарное русло имеет поражение 1 или 2 сосудов (результат SYNTAX ниже 32 баллов) и эффективность оптимальной медикаментозной терапии оказывается недостаточной.
АКШ: при наличии механических осложнений ИМ и осложнений при проведении ЧКВ, а также если коронарное русло имеет поражение 3 и более сосудов (результат SYNTAX выше 32 баллов), или имеется поражение левой коронарной артерии, или сопутствующая сердечная недостаточность.
ЭКС: при острых клинических ситуациях, сопровождающихся повышением риска возникновения жизнеопасных аритмии и асистолии.
ВАБК: состояния, сопровождающиеся левожелудочковой недостаточностью: кардиогенный шок, желудочковая тахикардия и др

**(ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ/ДИЕТА)**

| Режим питания | Уровень и тип медицинской помощи | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Амбулаторная помощь | | Стационарная помощь | | |
| Диетический стол и его продолжительность | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Районные (городские) больницы | Учреждения здравоохранения областного уровня | Учреждения здравоохранения республиканского уровня |
| 1. 10-й стол пожизненно | + | + | + | + | + |

**(РЕАБИЛИТАЦИЯ)**

| Реабилитационные мероприятия | Название медицинских услуг | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Минимальное количество мероприятий | Продолжительность реабилитации. |
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация специалиста (врача) | 1. Медсестра | + | | По показаниям, согласно рекомендации специалиста | Агар бемор ЎМИ, ТОКА ва АКШ ўтказ бўлган, реабилитация 1 йил давомида ўтказилиши лозим. |
| | 2. Семейный врач | + | | | |
| | 3. Кардиолог | | + | | |
| | 4. Терапевт | | + | | |
| | 5. Диетолог | | + | | |
| | 6. Инструктор ЛФК | | + | | |
| | 7. Психолог с медицинским образованием | | + | | |
| Примечание: Все узкие специалисты приглашаются по показаниям. | | | | | |
| Лабораторные исследования | 1. Общий анализ крови | + | + | По показаниям, после осмотра врача | |
| | 2. Общий анализ мочи | + | + | | |
| | 3. АЛТ, АСТ, билирубин | + | + | | |
| | 4. Липидный спектр | + | + | | |
| | 5. Уровень сахара в крови | + | + | | |
| | 6. Креатинин | + | + | | |
| Примечание: Анализы крови рекомендуются для оценки эффективности и безопасности медикаментов. | | | | | |
| Инструментал текширувлар | 1. ЭКГ | + | + | По показаниям, после осмотра врача | |
| | 2. ЭхоКГ | | + | | |
| | 3. ХМЭКГ | | + | | |
| | 4. ВЭМ или тредмил-синамаси | + | + | | |
| Примечание: ВЭМ (велоэргометрия) или тредмил тест рекомендуется для оценки прогноза по оценки ССР и толерантности к физической нагрузке, эффективности медикаментозной терапии | | | | | |
| Лечебные мероприятия (медикаментозные препараты | | Семейная поликлиника | Центральная многопрофильная поликлиника | Средняя суточная дозировка | Курсовая дозировка |
| Название лекарственного средства (международное непатентованное) | Дозировка и применение лекарственного средства." | | | | |
| 1. Ацетилсалицил | 75-150 мг1 раз в сутки | + | + | 75-150 мг | пожизненно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| кислотаси | | | | | |
| 2. Клопидогрел | 75 мг 1 раз в сутки | + | + | 75 мг | 1 йил |
| 3. Статинлар<br>- Розувастатин<br>- Аторвастатин | - Розувастатин 5-40 мг1 раз в сутки<br>- Аторвастатин 10-80 мг1 раз в сутки | + | + | - Розувастатин 5-40 мг<br>- Аторвастатин 10-80 мг | пожизненно |
| 4. РААТ блокаторлари:<br>А) ААФ ингибиторлари:<br>- Эналаприл<br>- Рамиприл<br>- Периндоприл<br>Б) АРБ (сартанлар):<br>- Валсартан<br>- Лозартан<br>- Кандесартан<br>- Телмисартан<br>- Азилсартан<br>- Олмесартан | ААФи:<br>- Эналаприл 2,5-20 мг суточная доза разделяется на два приёма - Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в сутки<br>- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>АРБ:<br>- Валсартан – 40-320 мг суточная доза разделяется на два приёма - Лозартан 25-100 мг 1 раз в сутки<br>- Кандесартан 4-32 мг 1 раз в сутки<br>- Телмисартан 10-80 мг 1 раз в сутки<br>- Азилсартан 20-80 мг 1 раз в сутки<br>- Олмесартан 10-40 мг 1 раз в сутки | + | + | ААФи:<br>- Эналаприл 2,5-20 мг<br>- Рамиприл 2,5-10 мг<br>- Периндоприл эрбумин 2-8 мг<br>- Периндопил аргинин 2,5-10 мг<br>АРБ:<br>- Валсартан – 40-320 мг<br>- Лозартан 25-100 мг<br>- Кандесартан 4-32 мг<br>- Телмисартан 10-80 мг<br>- Азилсартан 20-80 мг<br>- Олмесартан 10-40 мг | пожизненно |
| 6 Нитраты короткого действия:<br>- Нитроглицерин | Нитроглицерин 0,1-1,2 мг применяется только при приступах стенокардии сублингвально в форме таблетки или спрея | + | + | 0,1-1,2 мг | Только при приступах стенокардии |
| 5. Бета-блокаторлар:<br>- Бисопролол<br>- Метопролол<br>- Небиволол<br>- Карведилол | - Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в сутки<br>- Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Карведилол 3,125-25 мг суточная доза разделяется на два – три | + | + | - Бисопролол 2,5-10 мг<br>- Метопролол сукцинат 25-100 мг<br>- Небиволол 2,5-10 мг<br>- Карведилол 3,125-25 мг | пожизненно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **приёма** | | | | |
| **6. Блокаторы дегидропиридиновых кальциевых каналов:<br>- Амлодипин<br>- Лерканидипин<br>Нифедипин пролонгированного действия** | **- Амлодипин 2,5-10 мг 1 раз в сутки<br>- Лерканидипин 5-20 мг 1 раз в сутки<br>- Нифедипин ретард 30-60 мг 1 раз в сутки** | **+** | **+** | **- Амлодипин 2,5-10 мг<br>- Лерканидипин 5-20 мг<br>- Нифедипин ретард 30-60 мг** | **пожизненно** |
| **15. АМКР:<br>- Спиронолактон<br>- Эплеренон** | **- Спиронолактон 25-100 мг, 1-3 раза в сутки<br>- Эплеренон 25-50 мг, 1 раз в сутки** | **+** | **+** | | |
| **Примечание: Состав медикаментозной терапии может изменяться в зависимости от тяжести заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.** | | | | | |

**(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)**

| **Мероприятия по диспансеризации** | **Медицинские услуги** | **семейная поликлиника** | **Центральная многопрофильная поликлиника** | **Минимальное количество мероприятий** | **Продолжительность диспансерного наблюдения** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Консультация специалиста (врача)** | **1. Медсестра** | **+** | **+** | **Для перенесших ОИМ 4 раза в год** | **1 год** |
| | **2. Семейный врач** | **+** | | | |
| | **3. Кардиолог** | | **+** | | |
| | **4. Невролог** | | **+** | | |
| | **5. Эндокринолог** | | **+** | | |
| | **6. Нефролог** | | **+** | | |
| | **7. Офтальмолог** | | **+** | | |
| **Примечание: Повторные осмотры проводятся с целью оценки ССР. При высоком ССР количество повторных осмотров может быть увеличено.** | | | | | |
| **Лабораторные исследования** | **1. Общий анализ крови** | **+** | **+** | **Для перенесших ОИМ 4 раза в** | |
| | **2. Общий анализ мочи** | **+** | **+** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3. Сахар в крови** | **+** | **+** | **год** | |
| | **4. Креатинин** | **+** | **+** | | |
| | **5. Липидный спектр** | | **+** | | |
| | **6. АЛТ, АСТ, общая КФК** | **+** | **+** | | |
| | **7. Коагулограмма** | **+** | **+** | | |
| **Примечание: В ходе периодических осмотров по показаниям рекомендуются дополнительные инструментальные исследования.** | | | | | |
| **Инструментальные исследования** | **1. ЭКГ** | **+** | **+** | **Для перенесших ОИМ 4 раза в год** | |
| | **2. ЭХОКГ** | | **+** | **По показаниям** | |
| | **3. ХМЭКГ** | | **+** | | |
| | **4. УЗИ БЦА** | | **+** | | |
| | **5. УЗИ внутренних органов** | | **+** | | |
| | **6. Стресс-ЭКГ (ВЭМ, тредмил-тест)** | **+** | **+** | | |
| **Примечание: В ходе периодических осмотров по показаниям рекомендуются дополнительные инструментальные исследования.** | | | | | |